

CUERPOS EXTRAÑOS ESOFAGOGÁSTRICOS

Carmen Villar Lucas, Raisa Quiñones Castro, Laura Rodríguez Martín.

INTRODUCCIÓN

La ingestión de cuerpos extraños constituye un importante problema de salud, tanto por su frecuencia, como por su morbilidad e incluso potencia mortalidad. Los niños son la población más afectada (80% del total); y entre los adultos, la incidencia es mayor en determinados colectivos como personas con retraso mental, alteraciones psiquiátricas y reclusos. Aproximadamente, 80-90% de los cuerpos extraños ingeridos atravesarán todo el tubo digestivo y serán expulsados por vía rectal sin producir ningún problema. No obstante, cuando el cuerpo extraño posee capacidad lesiva, por sus características (objetos punzantes, cortantes, de gran tamaño) o contenido, la situación es distinta, pudiendo aparecer complicaciones inherentes al cuerpo extraño, en sí mismo, o a las maniobras para su extracción.

VALORACIÓN INICIAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Los objetivos primordiales en una primera valoración son: excluir compromiso de la vía aérea (si existiera, requeriríamos la colaboración urgente de ORL), descartar la existencia de complicaciones graves como la perforación y confirmar la presencia y localización del cuerpo extraño.

Una buena anamnesis es la herramienta más útil para concretar las características del cuerpo extraño y su capacidad lesiva, el tiempo desde su ingesta y la existencia de factores predisponentes (trastornos motores esofágicos, cirugía previa, ERGE...). Aunque la exploración física suele ser normal, es importante descartar la presencia de crepitación por enfisema subcutáneo, ya que es signo de perforación.

Para confirmar la existencia del cuerpo extraño, localizarlo y excluir complicaciones se indicará habitualmente una radiografía simple de tórax, abdomen y/o cervical según los casos, o una TC ante la sospecha de complicación.

CUERPOS EXTRAÑOS ESOFÁGICOS

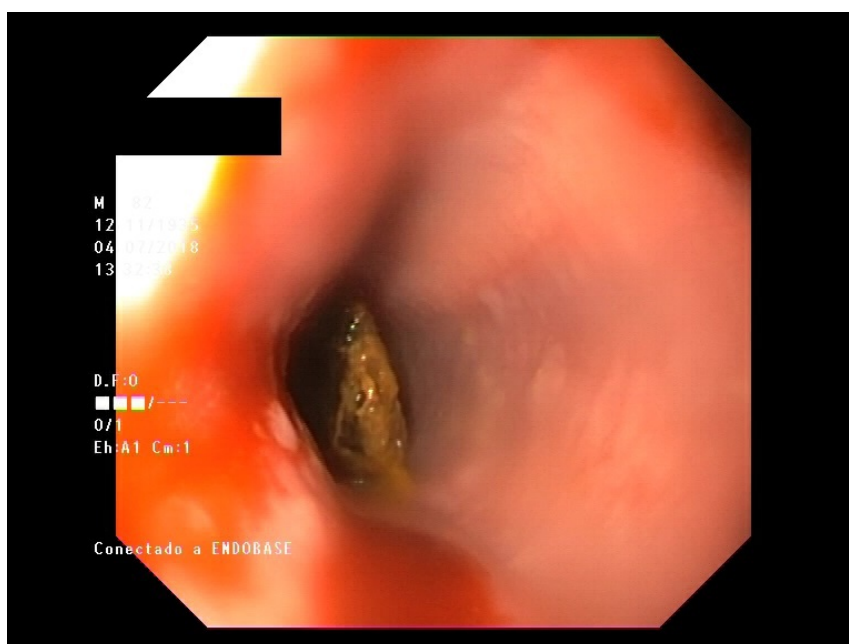
Son los más frecuentes y la actitud terapéutica dependerá fundamentalmente de las características y el potencial lesivo del mismo.

Bolo de carne

Es la situación más frecuente en los pacientes adultos, especialmente cuando presentan patología esofágica coexistente. En caso de que presente sialorrea implica obstrucción completa, por lo que deberá realizarse endoscopia urgente en menos de 6 horas. En ausencia de sialorrea podemos administrar un relajante del músculo liso (glucagón 1,5-2 mg en bolo i.v., o diazepam 5 mg i.v. lento y diluido) y si el cuadro no se resuelve en 12 horas, proceder a la extracción endoscópica.



Bolo de carne impactado en esófago distal



Hueso de melocotón impactado en esófago

Cuerpo extraño cortante o punzante

En estos casos el riesgo de complicaciones es elevado, por lo que se evaluará la posibilidad o no de extraerlo ponderando riesgo-beneficio y teniendo en cuenta factores como el material o el personal disponible.

Cuerpo extraño romo

Lo más frecuente en este grupo es la ingestión accidental de monedas por parte de los niños. Se recomienda endoscopia precoz, en 6-12 horas, considerando la sedación en niños o presos.

CUERPOS EXTRAÑOS GÁSTRICOS

Los cuerpos extraños que han alcanzado el estómago generalmente atravesarán el resto del tubo

digestivo sin provocar complicaciones, salvo si son cortantes/punzantes o de gran tamaño, por lo que el manejo será diferente según sus características.

Los cuerpos extraños cortantes/punzantes deben ser extraídos de forma urgente, para evitar complicaciones. En el caso de los que son romos, la actitud viene determinada por su tamaño y forma. Cuando se trata de cuerpos extraños redondeados de diámetro > 2-2,5 cm o de longitud > 5-7 cm, difícilmente progresarán por todo el tubo digestivo, y por ello resulta indicada su extracción endoscópica, antes de 24 horas. Si el diámetro o la longitud son inferiores se puede plantear la observación radiológica semanal, de tal manera que si no existe progresión tras un período prudente estimado en 3-4 semanas, convendría proceder a su extracción endoscópica.

PILAS

Las pilas pueden provocar lesión de la pared, por presión, por quemadura eléctrica y por fuga de las sustancias corrosivas que contienen. Las pilas convencionales son menos peligrosas que las alcalinas y mucho menos que las “pilas botón”, ya que estas últimas contienen elementos altamente cáusticos y pueden provocar perforación de la pared en pocas horas. Además, cuando se alojan en el esófago el riesgo de lesión mucosa es mucho mayor, mientras que si ya están en el estómago muy probablemente no ocasionarán problemas. Así, cuando la pila se encuentra en esófago debe ser extraída de forma urgente. Por el contrario, cuando la pila está en el estómago la actuación dependerá del tipo de pila. Si se trata de una pila botón se recomienda su extracción precoz-urgente. Para el resto de pilas alojadas en el estómago resulta razonable, tanto su extracción precoz como permitir su progresión espontánea con controles radiológicos.

PAQUETES DE DROGA

En el caso de ingestión de droga envuelta en pequeños paquetes, nunca debemos intentar su extracción endoscópica ya que nuestras maniobras pueden romper el continente, liberar el contenido y provocar la muerte por sobredosis. Resulta más prudente controlar la progresión de la/s bolsa/s radiológicamente hasta su expulsión espontánea por las heces.

BIBLIOGRAFÍA

- Santiago García-López, Kattalin Aspuru. Cuerpos extraños. En: Miguel Montoro, Juan Carlos García Pagán Editores. Gastroenterología y Hepatología, Problemas comunes en la práctica clínica. 2ª edición. Jarpay Editores, Madrid, Barcelona: 2012:229-42.
- ASGE Standards of Practice Committee, Ikenberry SO, Jue TL, Anderson MA, Appalaneni V, Banerjee S, Ben-Menachem T, Decker GA, Fanelli RD, Fisher LR, Fukami N, Harrison ME, Jain R, Khan KM, Krinsky ML, Maple JT, Sharaf R, Strohmeyer L, Dominitz JA. Management of ingested foreign bodies and food impactions. *Gastrointest Endosc* 2011;73:1085-91.
- Sugawa C, Ono H, Taleb M, Lucas CE. Endoscopic management of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract: A review. *World J Gastrointest Endosc* 2014;6:475-81.